

POP: INTEGRACAO PCMSO E PGR

Procedimento Operacional Padrao de Gestao de SST — NR-1 e NR-7

1. Objetivo e Campo de Aplicação

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) estabelece as diretrizes e os fluxos práticos para a **integração técnica e operacional** entre o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR - NR-1) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO - NR-7) dentro do ambiente do Mercado Atacadista. O objetivo principal é unificar as ações de Recursos Humanos (RH), Departamento Pessoal (DP) e Segurança e Saúde no Trabalho (SST), assegurando que o PCMSO utilize o Inventário de Riscos do PGR como fundamento primário para exames ocupacionais, e que os dados de saúde (atestados, restrições e afastamentos) sirvam como gatilhos ativos para reavaliação de riscos e melhoria contínua das condições de trabalho.

2. O Ecossistema de Integração e o eSocial

A gestão moderna de SST abandonou o modelo estático de elaboração de laudos avulsos. Em conformidade com as regras vigentes, o eSocial atua como o receptor digital da consistência operacional das empresas. O **GRO (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais)** funciona como o cérebro da gestão, enquanto o **PGR** é a sua materialização documental. Os dados técnicos gerados no Inventário de Riscos e no Plano de Ação alimentam o evento **S-2240 (Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos)**. Simultaneamente, o PCMSO, que é alimentado pelas exposições levantadas no PGR, define os exames do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), cujos dados são transmitidos tempestivamente no evento **S-2220 (Monitoramento da Saúde do Trabalhador)**.

ALERTA DE FISCALIZAÇÃO DIGITAL: O governo federal unificou o banco de dados do *Meu INSS* ao *SUS Digital* por meio do cruzamento de CPFs em toda a rede de atendimento pública e privada. Esse cruzamento de dados agiliza a caracterização automática do **Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP)**, impactando diretamente a alíquota do **FAP (Fator Acidentário Previdenciário)** e gerando passivos tributários para empresas com altos índices de CIDs ergonômicos (Grupo M) ou mentais (Grupo F). A consistência técnica entre as queixas de saúde e as avaliações no PGR é o único mecanismo de blindagem jurídica.

3. Procedimento Operacional: Fluxo de Entrada e Ações

PASSO 1: Fluxo de Recepção de Atestados no DP/RH

O Departamento Pessoal ou Recursos Humanos deve categorizar todos os atestados médicos recebidos em um período máximo de 48 horas. A triagem deve focar no mapeamento epidemiológico de atestados repetitivos e recorrentes, especialmente aqueles que envolvem o **Grupo F (Transtornos mentais e do comportamento)** e o **Grupo M (Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo)**. Sempre que um setor apresentar uma concentração anômala de atestados desses grupos, o DP emitirá um Alerta de Investigação Epidemiológica para o SESMT/SST.

PASSO 2: Diagnóstico Ativo e Metodologia de Triangulação de Campo

Ao receber o alerta epidemiológico do RH, o SESMT ou o profissional de SST deverá realizar um diagnóstico ativo utilizando a metodologia da **Triangulação Ergonômica** (exigida tecnicamente pela ergonomia e recomendada pelo MTE). Este método consiste em coletar dados de três fontes para obter um diagnóstico robusto:

Vértice 1	Observação de Campo	Análise visual direta das condições físicas, ambientais, mobiliário e postos de trabalho
Vértice 2	Vivência do Trabalhador	Escuta participativa por meio de diálogos individuais, grupos focais ou aplicação de
Vértice 3	Análise Documental	Verificação técnica do histórico de atestados, descrições de cargo vigentes e proced

PASSO 3: Atualização do Inventário de Riscos (NR-1)

A ocorrência de adoecimento relacionado ao trabalho é um dos **6 gatilhos regulamentares** que obrigam a reavaliação imediata da avaliação de riscos do PGR (NR-1, item 1.5.4.4.6). A equipe multidisciplinar de SST deve realizar os seguintes passos técnicos:

- **Recalcular o Nível de Risco Ocupacional (NRO):** Aplicar a fórmula *Probabilidade (P) x Severidade (S) = NRO* na matriz 5x5, elevando a probabilidade para a gradação máxima caso medidas protetivas específicas exigidas em NR estejam descumpridas.
- **Aumentar a Prioridade por Volume de Expostos:** Utilizar o multiplicador de trabalhadores possivelmente atingidos pelo mesmo risco. Entre dois riscos de mesma nota, o risco com maior número de expostos deve ser priorizado no Plano de Ação.
- **Registrar as Incertezas Técnicas:** Documentar as premissas e justificativas técnicas que levaram ao julgamento da classificação de risco para garantir rastreabilidade.

PASSO 4: Elaboração do Plano de Ação Focado na Causa Raiz

Ao propor medidas de prevenção, o comitê de SST deve aplicar estritamente a **Hierarquia de Medidas de Prevenção** (NR-1, item 1.5.5.1.2), priorizando soluções de Engenharia/Coletivas e Organizacionais sobre as Medidas Individuais ou Comportamentais. Para riscos ergonômicos organizacionais e psicossociais, oferecer paliativos individuais (como palestras motivacionais, treinos de resiliência ou aplicativos de meditação) para trabalhadores sobrecarregados por metas abusivas é uma prática incorreta que caracteriza inconformidade sob fiscalização. A ação deve atuar diretamente no desenho e organização do trabalho.

Tipo de Medida	Exemplos Aplicados (Causa Raiz)	Objetivo no Trabalho Real
Eliminação / Substituição	Substituir fardos pesados por leitores de código de barras sem fio de tipo portátil e portáteis	Eliminar o esforço físico intenso
Proteção Coletiva (Engenharia)	Robôs enrolantes automatizados e check-out de segurança visível e acessível	Adaptar o ambiente às características psicofisiológicas
Administrativa / Organizacional	Revisão política de desconto por 'quebra de caixa'	Complementar o ASO com medidas de controle de custos, reduzindo
Informação / Treinamento	Treinar líderes em Comunicação Não-Violenta	Atuar em conjunto com a gestão para mitigar os

PASSO 5: Integração Médica e Compliance com o eSocial

Uma vez implementada a medida, o SESMT deve comunicar imediatamente o Médico Coordenador do PCMSO. O PCMSO deve ser readequado para ajustar os exames ocupacionais (retirando ou adicionando exames complementares de acordo com os riscos residuais). Esse alinhamento garante que o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido reflita estritamente o ambiente atualizado do trabalhador, permitindo o correto envio do evento **S-2220** ao eSocial e evitando inconsistências com o evento **S-2240**, o que causaria malhas fiscais previdenciárias.

4. Rastreabilidade, Governança e Guarda de Dados

O gerenciamento de riscos ocupacionais (GRO) é um processo dinâmico e iterativo. Toda reavaliação de riscos e atualização de planos de ação deve deixar um rastro auditável na organização. De acordo com o item 1.5.7.3.3.1 da NR-1, o histórico de atualizações do Inventário de Riscos Ocupacionais deve ser mantido por um período mínimo de **20 (vinte) anos**. A responsabilidade legal de guarda e disponibilização desse histórico às autoridades competentes e sindicatos é exclusiva da organização contratante, independentemente de mudanças posteriores de profissionais de SST ou softwares de gestão de terceiros.

DICA DE GOVERNANÇA: Ao migrar ou alterar softwares de SST ou consultorias de campo, o RH e o DP devem garantir a exportação completa de todo o histórico rastreável em formato aberto para fins de defesa de fiscalizações retroativas. Não ter o rastro de revisões indica para a auditoria que a empresa operou sem controle.